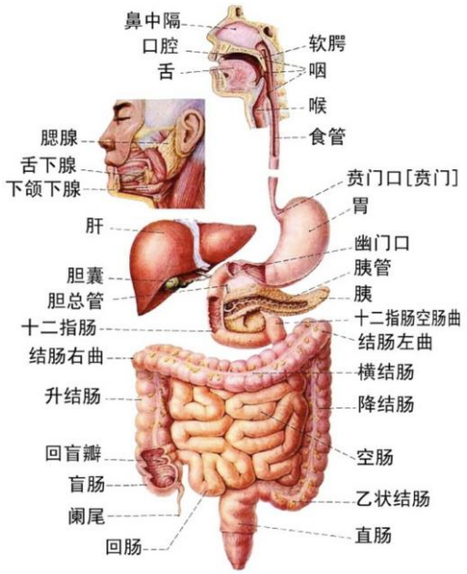
核心精讲·慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、慢性胃炎

1.非萎缩性/浅表性/单纯性胃炎：胃窦常见，黏膜浅层淋巴细胞和浆细胞浸润

多数胃炎与HP有关　慢性炎细胞:淋浆

HP常出现在胃窦处

2.萎缩性胃炎

黏膜色泽变浅

（1）**特征：黏膜变薄、皱襞变浅、黏膜下血管清晰可见、腺体变小和减少、胃小凹变浅**　特征在于“萎缩”

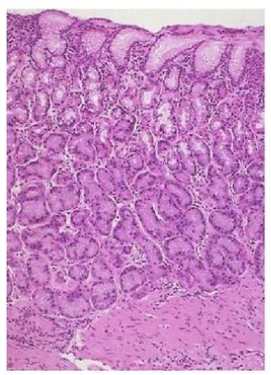
淋巴细胞堆在一起

及囊性扩张，淋巴细胞和浆细胞浸润（病程长者可形成 ttsx 淋巴滤泡）、纤维化

慢性丙肝、桥本甲状腺炎也有淋巴滤泡　肉芽组织纤维性修复

慢性炎症特点

正常胃底黏膜　慢性萎缩性胃炎





病理目录

第一章 消化系统　1

1. 慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病	1
2. 病毒性肝炎	6
3. 肝硬化	13
4. 原发性肝癌	20
串·消化系统恶性肿瘤概述	22
5. 消化道肿瘤	24

第二章 心血管　32

1. 感染性心内膜炎	32
2. 风湿病	33
3. 高血压	37
4. 动脉粥样硬化	40
5. 心肌疾病	47

第三章 呼吸系统疾病　52

1. 慢支炎、肺气肿、肺心病	52
2. 支扩	66
3. 肺硅沉着病	68
4. 肺炎	70
5. 呼吸系统肿瘤	75

第四章 内分泌系统疾病　79

第五章 免疫性疾病　85

第六章 生殖系统疾病　93

第七章 乳腺疾病　105

第八章 传染　108

1. 结核	108
2. 其它传染病	116
串·常考溃疡	121

第九章　123

1. 损伤的修复	123
2. 适应和损伤	130
①适应	130
②可逆性损伤/变性	134
③坏死	138
3. 局部血液循环障碍	149
4. 炎症	159
串·常考肉芽肿	170
5. 肿瘤	172

消化道除了口腔,食管,肛门外其他地方都不是鳞状上皮,如胃、肠道是腺上皮

（2）腺上皮化生 一种细胞→另一种细胞 ①

假幽门腺化生	小肠是主要的吸收部位
肠上皮化生（常见）②	完全型/小肠型/I型：含有杯状、吸收、潘氏细胞
可有不典型/异型增生→可能癌变	不完全型/II型：含有杯状细胞
增生的细胞跟原来的细胞相比出现差异	①胃型/IIa 型
不典型增生/异型增生见于:肿瘤、某些癌前病变	②结肠型/IIb 型→可能导致肠型胃癌 大 2B ③

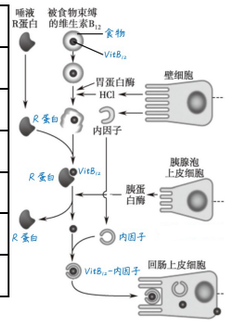
化生:慢支炎→支气管假复层纤毛柱状上皮鳞状化生　先存在肠上皮细胞化生,在此基础上发生胃癌

（3）A 型 VS B 型胃炎

G→胃泌素↑→壁细胞→HCl↓　胃泌素对胃酸促进作用↓,但促进胃酸分泌的因素不只胃泌素,所以胃酸正常或↓

	A 型胃炎	B 型胃炎（常见）
病因	自身免疫	Hp（常伴消化性溃疡）
抗壁细胞和内因子抗体	+	-
好发部位	胃体、胃底	G细胞在胃窦幽门部胃窦
胃酸分泌	明显↓（缺乏）	正常或↓
血胃泌素	↑	G细胞受损 ↓
血 $VitB_{12}$	↓（常伴恶性贫血）④	正常 ⑤

分泌HCl和内因子　壁细胞存在胃体　负反馈



内因子帮助VitB12 在回肠吸收　多种原因→VitB12/叶酸缺乏→巨幼贫　由内因子↓→VitB12↓→巨幼贫→恶性贫血

胃酸减少 ? → 巨幼贫 ⑥

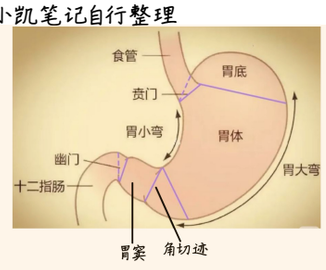
内因子 → VitB12　HCl　胰蛋白酶　少量胃酸就可以使VitB12从食物中放出来　所以胃酸缺乏会导致巨幼贫

二、消化性溃疡

1.病因：Hp，防御屏障↓和侵袭因素↑等 天平失衡

	胃溃疡	十二指肠溃疡（常见）
好发年龄	中老年 小老 dou 老胃病	青壮年
好发部位	胃窦小弯侧	球部前壁

小凯笔记自行整理



胃窦小弯又叫角切迹,应力改变更明显

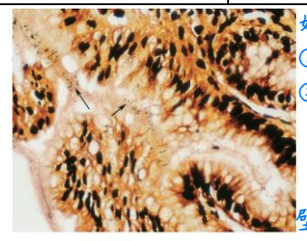


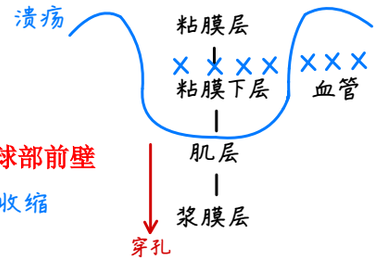
图 11-2　幽门螺杆菌

沃森 - 斯塔里银染色（Warthin-Starry 银染色）示幽门螺杆菌呈黑色弯曲棒状（箭头），黏附于胃黏膜（胃小凹）表面，细胞核为黑色。

好发于球部前壁原因:
①十二指肠球部最靠近胃窦部,容易遭受HP的破坏
②胃酸直接进入十二指肠球部,加上前壁是游离的,非常薄

壁细胞数量决定胃酸最大分泌量
十二指肠溃疡患者壁细胞数量比正常人多,产生的胃酸也多

2.并发症



①出血：最常见
与溃疡好发部位一致

②穿孔：胃溃疡好发于胃小弯、十二指肠溃疡好发于球部前壁

③幽门狭窄　溃疡出现肉芽组织纤维性修复,胶原纤维一收缩→幽门梗阻

④癌变：胃溃疡癌变率多＜1%（来自溃疡边缘）；十二指肠溃疡几乎不癌变
做胃镜时从溃疡边缘取活检

① 1. 上皮组织的化生
(1)鳞状上皮的化生:被覆上皮组织的化生以鳞状上皮化生最为常见,简称鳞化。如吸烟者支气管假复层纤毛柱状上皮易发生鳞状上皮化生;唾液腺、胰腺、肾盂、膀胱和肝胆发生结石或维生素A缺乏时,被覆柱状上皮、立方上皮或尿路上皮都可化生为鳞状上皮。
(2)柱状上皮的化生:腺上皮组织的化生也较常见。慢性胃炎时,胃黏膜上皮转变为含有潘氏细胞或杯状细胞的小肠或大肠黏膜上皮组织,称为肠上皮化生,简称肠化;若胃窦、胃体部腺体由幽门腺所取代,则称为假幽门腺化生。慢性反流性食管炎时,食管下段鳞状上皮也可化生为胃型或肠型柱状上皮。
2. 间叶组织的化生
间叶组织中幼稚的成纤维细胞在损伤后,可转变为成骨细胞(骨母细胞)或成软骨细胞(软骨母细胞),称为骨或软骨化生。这类化生多见于骨化性肌炎等受损软组织,也见于某些肿瘤的间质。

② 不典型增生/异型增生常见于肿瘤、某些癌前病变。肿瘤细胞与正常细胞不相同,故肿瘤细胞中有不典型增生。但对于癌前病变而言,只有某些癌前病变才有不典型增生,例如萎缩性胃炎。反例,肝硬化是肝癌的癌前病变,但它没有不典型增生。

③ 正常的支气管上皮细胞为柱状上皮,即腺上皮的一种。当柱状上皮。当柱状上皮化生为鳞状上皮时,发生的肺癌为鳞癌,此肺癌与化生有关。同理,胃的正常组织为腺上皮,当胃发生肠上皮化生时,称为肠型胃癌,此类胃癌与化生有关。

④ 恶性贫血是巨幼贫的一种特殊类型,特指由A型胃炎导致的巨幼贫。

⑤ A型胃炎的患者,自身抗体攻击壁细胞和内因子。
壁细胞可以产生盐酸和内因子,所以A型胃炎的患者盐酸分泌明显缺乏及内因子减少。内因子可以帮助VitB12回家,内因子减少会导致VitB12吸收障碍,出现巨幼贫(恶性贫血)。
壁细胞位于胃底、胃体,A型胃炎患者的好发部位位于胃底、胃体。
G细胞产生胃泌素,胃泌素作用于壁细胞使其分泌盐酸,盐酸对于壁细胞和G细胞本身都会存在负反馈作用。A型胃炎的患者盐酸明显减少,通过负反馈让胃泌素增加。

B型胃炎的患者病因是Hp,Hp存在于胃窦部,所以B型胃炎的好发部分是胃窦部。胃窦部有G细胞,其产生胃泌素,,G细胞受到攻击数量减少,所以血胃泌素减少。
胃酸由壁细胞产生,壁细胞没有受到攻击,所以胃酸可以正常。但促进胃酸分泌因素中最重要的是胃泌素,现在胃泌素减少,所以胃酸也可以减少。

⑥ 内因子的缺乏、胃酸的缺乏、胰蛋白酶的缺乏,都会让VitB12的吸收减少,进而引起巨幼贫。其中,胃酸一定是缺乏才会导致巨幼贫。

注意：GU 好发部位、出血好发部位、穿孔好发部位在胃小弯；DU 好发部位、急性穿好发部位在球部前壁，而 DU 出血和慢性穿孔好发部位在球部后壁袜子-前面穿孔、后面出血

小凯笔记自行整理

- GU：好发部位、穿孔部位、出血部位 → 胃小弯
- DU：好发部位、穿孔部位（急性穿孔→十二指肠球部前壁；慢性穿孔→十二指肠球部后壁）、出血部位

3.胃溃疡的病理变化

（1）圆形或椭圆形、多＜2cm、边缘整齐如刀切、底部平坦、深达肌层、阶梯状（贲门侧深+幽门侧浅本身有钱），**周围黏膜皱襞呈放射状向 ttsx 溃疡集中**（溃疡底部瘢痕牵拉）

VS 胃癌溃疡 火山口或皿状，多>2cm，边缘不整齐，底部凹凸不平，深度较浅

（2）溃疡底部由内向外 机体在慢慢修复，肉芽组织从底部开始长，越靠近外面越陈旧

新 ↓ 旧

①炎性渗出层：中性粒细胞等白细胞、纤维素（纤维蛋白）

②坏死组织层：伊红色坏死组织（**纤维素样坏死**）=胶原纤维的坏死（染色染出来与纤维素一样）

③**肉芽组织**层：大量新生毛细血管和成纤维细胞 →产生胶原纤维

④瘢痕组织层：**增殖性/闭塞性动脉内膜炎**（管腔狭窄闭塞、血栓形成）→影响再生使溃疡

不易愈合、但**防止溃疡血管破裂出血**

肌层破坏不能完全再生



图 11-3　胃溃疡

胃小弯近幽门处溃疡，边缘整齐，周围黏膜水肿，黏膜皱襞向周围放射状排列。

胶原纤维收缩

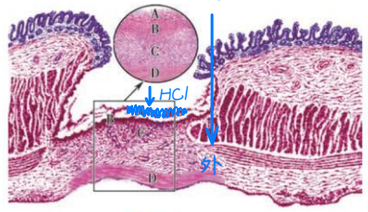
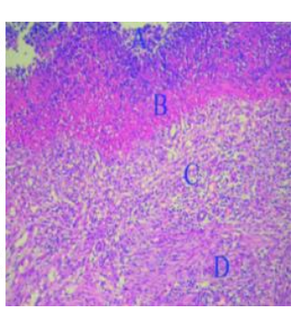


图 11-4　胃溃疡

溃疡断面呈斜置漏斗状，深达肌层，溃疡底部由内向外分为四层：A 为炎性渗出层；B 为坏死组织层；C 为肉芽组织层；D 为瘢痕层。



4.结局：渗出物及坏死组织逐渐被吸收、排出，已被破坏的肌层不能再生，由底部的**肉芽组织**增生形成瘢痕组织修复，同时周围**黏膜上皮再生**覆盖溃疡面而愈合

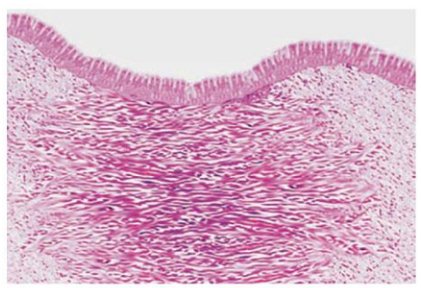


图 11-5　消化性溃疡愈合

⑦ 胃溃疡的好发部位、胃溃疡出血的好发部位、胃溃疡穿孔的好发部位都在胃小弯。十二指肠溃疡的好发部位、急性穿孔的好发部位在球部前壁；十二指肠溃疡出血好发部位在球部后壁（血管主要在后面），慢性穿孔的好发部位也在球部后壁（在后面慢慢穿孔）。
如果题目只说穿孔，默认是急性穿孔。

⑧ 胃溃疡给人乖乖的感觉，胃癌给人乱七八糟的感觉。值得注意的是，胃溃疡的深度要比胃癌的深度深，但并不代表胃癌是浅溃疡，只是相对于胃溃疡来说深度较浅。

⑨ 胃溃疡是慢性炎症，为何是中性粒细胞渗出。原因一，幽门螺杆菌会分泌趋化因子，吸引中性粒细胞的聚集。原因二，胃溃疡虽然为慢性炎症，但炎性渗出层是活动期，以中性粒细胞渗出为主。

⑩ 纤维素样坏死指的是胶原纤维发生了坏死：急进型高血压、风湿、类风湿、新月体性肾炎、重症急性肾炎、结节性多动脉炎、胃溃疡、SLE、超级性排斥反应、1型糖尿病、SARS/MERS、COVID-19。（高风亮节、喂狼超糖）

三、急性阑尾炎 强调早期手术,越早期越单纯好治

（1）**中性粒细胞**等浸润

（2）①单纯性、②**化脓性（蜂窝织炎）**、③坏疽穿孔性（可致弥漫性腹膜炎、阑尾周围脓肿）

②大量中性粒细胞浸润　皮肤、肌肉、阑尾等疏松结缔组织的化脓性炎

③腹膜刺激症　穿孔内容物被大网膜包起来

炎症类型举例

变性坏死
①**变质**性炎：乙脑、阿米巴、病毒性肝炎等

②**纤维素**性炎：假膜性炎/黏膜的纤维素性炎（细菌性痢疾和白喉假的立白）、绒毛心、大叶性肺炎等

累及肺泡

③**化脓**性炎：小叶性肺炎、流脑、淋病、急性阑尾炎等

绒毛心→缩窄性心包炎
大叶性肺炎→肺肉质变
→ 大量渗出纤维素无法完全被溶解，被肉芽组织机化

四、胰腺疾病

1.急性胰腺炎

①水肿性/轻型（常见）

②出血坏死性/重型：胰腺明显肿大、大量出血、胰腺大片凝固性坏死、胰腺周围**脂肪坏死**

高血压/动脉粥样硬化→脑软化(液化性坏死)　胰脂肪酶提前激活水解脂肪

（特殊液化性坏死）、黄白色斑点（**钙皂**）

肠腔的脂肪酸与Ca2+形成钙皂→抓住Ca2+,利于Ca2+在肠道吸收

VS 急性重症/出血坏死性胰腺炎:脂肪坏死→脂肪酸与血液中的Ca2+形成钙皂→低钙血症

2.胰腺癌

①好发部位：胰头　VS 胰腺炎多为胰体、胰尾

②最常见组织学类型：导管腺癌

真题解析·慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N166 X 胃溃疡的镜下病理特征有

A.纤维瘢痕形成

B.肉芽肿形成

C.闭塞性动脉内膜炎

D.纤维蛋白和中性粒细胞渗出

肉芽组织 VS 肉芽肿
纤维性修复　增生性炎症
单核巨噬细胞增生

2.2015N167 X 以下选项中，属于慢性萎缩性胃炎的病变有

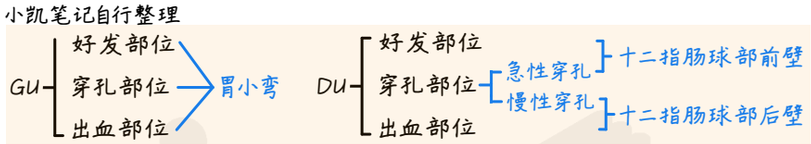
A.胃黏膜慢性炎细胞浸润 淋浆

答案：1-2 ACD ABC

B.肠上皮化生
C.幽门螺杆菌阳性 B型胃炎更常见
D.鳞状上皮化生 腺上皮化生

3.2019N151 X 消化性溃疡的好发部位为
A.十二指肠球部
B.十二指肠升部
C.胃窦部小弯侧
D.胃窦部大弯侧

小凯笔记自行整理



4.2022N150 X 消化性溃疡发生游离性穿孔的常见部位有
A.胃小弯
B.十二指肠球部前壁
C.胃大弯
D.十二指肠球部后壁

以题带动
知识点复习

5.2023N36 A 胃体黏膜活检可见大量假幽门腺化生，病理诊断是
A.慢性浅表性胃炎
B.慢性萎缩性胃炎
C.慢性肥厚性胃炎
D.疣状胃炎

思维导图·慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：3-5 AC AB B